

TEMA 4.21 • GASTROENTEROLOGÍA

Diarrea en Niños

Reflujo, Dolor Abdominal y Constipación en Pediatría

1. Reflujo Gastroesofágico del Lactante

Fisiológico vs. Patológico

TABLA 4.21.1: CLASIFICACIÓN Y CRITERIOS CLÍNICOS		
	REFLUJO FISIOLÓGICO	REFLUJO PATOLÓGICO
Aspecto del lactante	Lactante feliz	Malestar, irritabilidad
Incremento ponderal	Normal	Mal incremento (baja o no sube de peso)
Hemorragia digestiva	No	Posible
Síntomas respiratorios	No	Sí (bronquitis obstructiva, asma)
ALTE	No	Posible (ahogamiento por aspiración)
Conducta	Educación, tranquilizar	Estudiar + tratar

NOTA CLÍNICA
Pico de regurgitación fisiológica: 2–6 meses. Desaparece espontáneamente al año-año y medio. Frase clásica: "las únicas guaguas que no vomitan son las que no toman leche."

Diagnóstico

- Clínico para la mayoría
- pHmetría de 24 h si hay duda (igual que en adultos)

Tratamiento

- **Primera línea: Omeprazol (IBP)** — igual que en adultos
- - NO domperidona ni metoclopramida como primera línea (riesgo de síntomas extrapiramidales)
- **Segunda línea:** procinéticos (domperidona si IBP insuficiente)
- **Antihistamínicos H2** (ranitidina, famotidina): alternativa si alergia a IBP
- **Cirugía** (funduplicatura de Nissen): última línea, solo si reflujo patológico grave sin respuesta a tratamiento médico

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN
Domperidona y metoclopramida = síntomas extrapiramidales (rigidez, tortícolis, trismus). No son primera línea. Si se usan → monitorear efectos adversos.

Diferencial: Estenosis Hipertrófica del Píloro

TABLA 4.21.2: CLASIFICACIÓN Y CRITERIOS CLÍNICOS		
	RGE PATOLÓGICO	ESTENOSIS HIPERTRÓFICA DEL PÍLORO
Inicio	Desde nacimiento	Semana 2–6 de vida
Vómitos	Regurgitaciones frecuentes	Vómitos explosivos, proyectivos
Examen	Normal	Oliva pilórica palpable a veces
Diagnóstico	Clínica / pHmetría	Ecografía (píloro engrosado)
Tratamiento	IBP ± cirugía	Piloro-tomía de Ramstedt

2. Dolor Abdominal Crónico en Pediatría

Con signos de alarma → Estudiar

- Signos de alarma que obligan a exámenes:
- Baja de peso
- Alteración del examen físico
- Vómitos o hemorragia digestiva
- Fiebre recurrente

→ ECO o TAC → tratar causa específica

Sin signos de alarma → Dolor Abdominal Psicógeno

- **Causa más frecuente** de dolor abdominal crónico en niños (no SII como en adultos)
- **Clues:**
 - - Aumenta con **estrés** (exámenes, inicio del año escolar)
 - - Disminuye en vacaciones o fin de semana
 - - Localización **periumbilical** (los niños señalan el ombligo al decir que les duele la guata)
- **Tratamiento:** tranquilizar, educar, manejo del estrés

PERLA CLÍNICA EUNACOM
Niño que siempre duele los lunes antes del colegio y está bien los sábados → dolor psicógeno periumbilical. Es la causa más frecuente, pero siempre hay que descartar organicidad.

3. Constipación y Fecaloma en Pediatría

Diagnóstico de Constipación

- ≤ 2 evacuaciones por semana
- Deposiciones duras, en bolita o muy voluminosas
- Dolor al defecar (por tamaño y dureza)
- Fecaloma (confirma constipación importante)

Círculo Vicioso

''' Constipación → Bolo fecal duro → Fisura anal → Dolor → Miedo a defecar → Constipación '''

Fecaloma — Clínica

- **Masa abdominal palpable** (causa más frecuente de masa abdominal en pediatría)
- **Pseudo-incontinencia fecal** (rebalsamiento de feces líquidas alrededor del fecaloma)
- **Encopresis:** deposición involuntaria mientras duerme
- Manchado de calzoncillos (ensuciamiento constante)
- **Diagnóstico:** tacto rectal (se palpa la masa fecal dura en el recto)

EUNACOM CRITERIOS
Consejo jurídico-médico: Al realizar tacto rectal en niños → **siempre con testigo** (enfermera o auxiliar) y **dejar registro en ficha** con la firma del testigo. Protege al médico de acusaciones.

Manejo de la Constipación — 2 Fases en Orden

Fase 1: Desimpactación (primero sacar el fecaloma)

TABLA 4.21.3: OPCIÓN VS DETALLE	
OPCIÓN	DETALLE
PEG (Macrogol/Polietilenglicol) VO — Elección	Más eficaz; oral
Enema evacuante	Igualmente eficaz; alternativa si falla el PEG o como primera opción
Si ambos fallan	Proctoclisís (irrigación rectal continua por sonda)
No recomendado	Desimpactación manual (doloroso, humillante, reservar solo excepcionalmente)

- Fase 2: Mantenimiento** (evitar que se repita)
- **Laxantes al menos 4 semanas** (romper el círculo vicioso)
 - **Hábito de defecación:** sentar al niño en el baño 5 min post-almuerzo diario
 - Dieta rica en fibra + agua
 - Educación sobre el proceso

EUNACOM CRITERIOS

Orden obligatorio: 1. Primero desimpactar (fase 1) 2. Luego mantener (fase 2)

Si se salta la fase 1 y solo se dan laxantes → el fecaloma no sale → empeora.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:

"Lactante de 10 meses con diarrea acuosa de 3 días de evolución, llanto sin lágrimas, mucosas secas y baja de peso del 7%. ¿Cuál es la conducta inicial más apropiada?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Diarrea en Niños. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- La diarrea aguda pediátrica es mayoritariamente viral (rotavirus); el manejo fundamental es la hidratación según grado de deshidratación
- Plan A: oral post-deposición; Plan B: SRO 50-100 cc/kg en 4-6 h; Plan C: SF IV bolo 20 cc/kg
- Antidiarreicos contraindicados en pediatría; antibióticos solo ante Shigella o E. coli enteroinvasora
- La diarrea crónica inespecífica (por jugos hiperosmolares) es la causa más frecuente de diarrea crónica en niños
- Fibrosis quística: diarrea + neumonías (Pseudomonas/Staphylococcus); diagnóstico con test del sudor (cloro mayor o igual a 60 confirmado)
- Alergia a proteína de leche de vaca: diagnóstico con prueba terapéutica de 4 semanas con reintroducción
- Enfermedad celíaca: anticuerpos antitransglutaminasa + biopsia duodenal; tratamiento con dieta sin gluten

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (DIARREA EN NIÑOS)

PREGUNTA 1

Lactante de 10 meses con diarrea acuosa de 3 días de evolución, llanto sin lágrimas, mucosas secas y baja de peso del 7%. ¿Cuál es la conducta inicial más apropiada?

- A) Sales de rehidratación oral 50-100 cc/kg en 4-6 horas
- B) Suero fisiológico IV en bolo de 20 cc/kg
- C) Agua libre por vía oral a libre demanda
- D) Ciprofloxacino oral
- E) Loperamida para disminuir las deposiciones

PREGUNTA 2

Preescolar de 4 años, procedente de zona rural, con diarrea crónica, flatulencia y dolor abdominal cólico. Otros miembros de la familia presentan síntomas similares. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- A) Diarrea crónica inespecífica
- B) Enfermedad celíaca
- C) Giardiasis
- D) Fibrosis quística
- E) Alergia a la proteína de leche de vaca

PREGUNTA 3

Lactante de 4 meses alimentado con fórmula presenta diarrea crónica, exantema cutáneo y episodios de sibilancias. ¿Cuál es el estudio diagnóstico más apropiado?

- A) Test del sudor
- B) Anticuerpos antitransglutaminasa
- C) Prueba terapéutica con fórmula hidrolizada por 4 semanas
- D) Parasitológico de deposiciones
- E) Endoscopia digestiva alta con biopsia

RESUMEN: DIARREA EN NIÑOS

Clase sobre diarrea aguda y crónica en pediatría. La diarrea aguda es mayoritariamente viral (rotavirus es el más frecuente) y el manejo se centra en la hidratación según grado de deshidratación: Plan A (oral, 100-200 cc post deposición) para leve, Plan B (SRO 50-100 cc/kg en 4-6 horas) para moderada, y Plan C (suero fisiológico IV en bolo 20 cc/kg) para severa o shock. Se revisan las causas de diarrea crónica pediátrica: la diarrea crónica inespecífica (más frecuente, por jugos hiperosmolares), giardiasis (preescolares/escolares, zona rural), enfermedad celíaca (malabsorción con anticuerpos antitransglutaminasa), fibrosis quística (diarrea + neumonías por *Pseudomonas* o *Staphylococcus*) y alergia a la proteína de leche de vaca (lactantes con fórmula, síntomas GI + alérgicos, diagnóstico con prueba terapéutica de 4 semanas). Los antibióticos en diarrea aguda se indican solo ante sospecha de *Shigella* o *E. coli* enteroinvasora (mal estado general, fiebre alta, disentería). Los antidiarreicos están contraindicados en pediatría.